

CHU BESANÇON Pôle mère femme	PRISE EN CHARGE D'UNE BARTHOLINITE		090 URG 210 PTXX 002 Version 1 Page 1 / 4
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

1 - **Concerne** : le personnel médical intervenant aux Urgences Gynécologiques.

2 - **Bibliographie** :

Conduite à tenir devant une Bartholinite, CNGOF, 2007, P. Descamps (1)

Place de l'antibiothérapie en première intention en cas de Bartholinite aiguë : à propos d'une série de 33 cas, Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 2019, C.Bertholdt et al. (2)

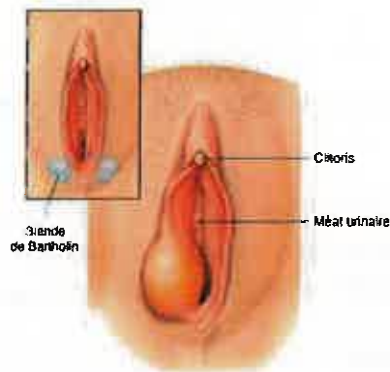
Traitement d'un abcès aigu de la glande de Bartholin par aspiration à l'aiguille simple : une étude prospective, AP-HM La Conception, Marseille, 2022, A. Charavil, L. Miquel et al. (3)

3 - **Application** :

a. Introduction

Les glandes de Bartholin sont des glandes hormono dépendantes situées en profondeur, dans le tiers postérieur du vestibule. Elles contribuent à la lubrification du vagin au cours des rapports sexuels.

Elles mesurent en moyenne 10 à 15 mm et possèdent un canal excréteur d'environ 2 cm dont l'orifice s'abouche à l'anneau hyménal.



L'abcès de la glande de Bartholin, appelé Bartholinite, est une pathologie bénigne, fréquente, qui affecte entre 1 et 3% des femmes. Il s'agit d'une infection aiguë localisée de la glande ou de son canal excréteur.

Elle touche généralement les femmes jeunes, âgées de 20 à 29 ans, nulligestes, et survient préférentiellement sur terrain diabétique.

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION : 31/07/2024 Lorenda CHRISTEN Interne Signature :	VERIFICATION : 10/10/2024 Mounine AICH Qualiticien – Direction Qualité Document signé	VALIDATION : 3 M 2024 Dr Anne-Sarah THOLOZAN JUNIAT Praticien Hospitalier Signature :	APPROBATION : 1...1... Pr Nicolas MOTTET PUPH Signature :
Liste de diffusion : urgences gynécologiques via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur Visuel de Gynécologie			
Relecture périodique du document - sans modification par : le :			

 Pôle mère femme	PRISE EN CHARGE D'UNE BARTHOLINITE		090 URG 210 PTXX 002 Version 1 Page 2 / 4
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

b. Diagnostic

Son diagnostic est clinique. Elle se présente comme une tuméfaction vulvopérinéale unilatérale douloureuse, lancinante, rouge et chaude, responsable d'une déformation locale.

c. Origine

L'infection se fait généralement par voie canalaire ascendante.

Les germes impliqués sont principalement des bactéries commensales du système digestif (entérobactéries, Escherichia Coli, bactéries anaérobies, etc) : l'infection est alors volontiers plurimicrobienne.

Par le passé, la voie sexuellement transmissible était responsable de la plupart des Bartholinites avec des germes responsables d'infections génitales hautes comme le Gonocoque, Chlamydia voire le Mycoplasme. Cependant, l'évolution des pratiques sexuelles en a modifié l'écologie bactérienne et ces germes sont dorénavant retrouvés surtout lors d'une co-infection par le VIH.

D'autres causes peuvent être à l'origine d'un abcès de la glande, notamment les causes iatrogènes après colporraphie postérieure par exemple (par ensemencement rétrograde du canal), par traumatisme lors de l'accouchement, ou encore par surinfection d'un kyste préexistant du canal excréteur (à l'origine d'une obstruction).

4 - Traitement :

Son traitement de référence est chirurgical, par incision-drainage (*recommandations du CNGOF, 2007*).

Néanmoins, quelques études de parution récente (2)(3), tendent à en modifier la prise en charge au profit de procédures moins invasives, telles que l'antibiothérapie en première intention, voire la ponction-aspiration à l'aiguille simple, desquelles s'inspire ce protocole.

a. Antibiothérapie seule

Un traitement par antibiothérapie seule peut être entrepris si les conditions suivantes sont réunies :

- Terrain favorable, pas de facteur de risque de complication (immunosuppression, diabète, grossesse, etc) ;
- Début des symptômes **inférieur à 3 jours** ;
- Aucune antibiothérapie antérieure initiée ;
- Absence de signes généraux d'infection ou de critères de gravité (fièvre, adénopathies, extension locorégionale, etc) ;
- **Collection de moins de 2 cm**, non fistulisée à la peau.

Le traitement initié sera préférentiellement de la **PRISTINAMYCINE 1 gramme 3 fois par jour, durant 7 jours**.

b. Antibiothérapie associée à une ponction-aspiration à l'aiguille fine

La ponction-aspiration à l'aiguille peut être réalisée, en association avec l'antibiothérapie, pour la prise en charge des Bartholinites « intermédiaires », c'est-à-dire ne relevant ni de la mise à plat chirurgicale d'emblée, ni du traitement antibiotique conduit seul, dans les situations suivantes :

- Terrain favorable, absence de facteur de risque de complication (immunosuppression, diabète, grossesse, etc) ;
- Début des symptômes **supérieur à 3 jours** ;
- Absence d'amélioration sous antibiothérapie débutée il y a moins de 7 jours et **sans aggravation** manifeste de la situation clinique ;
- Absence de signes généraux d'infection ou de critères de gravité (fièvre, adénopathies, extension locorégionale, etc) ;
- **Collection mesurant entre 2 et 5 cm**, non fistulisée à la peau ;

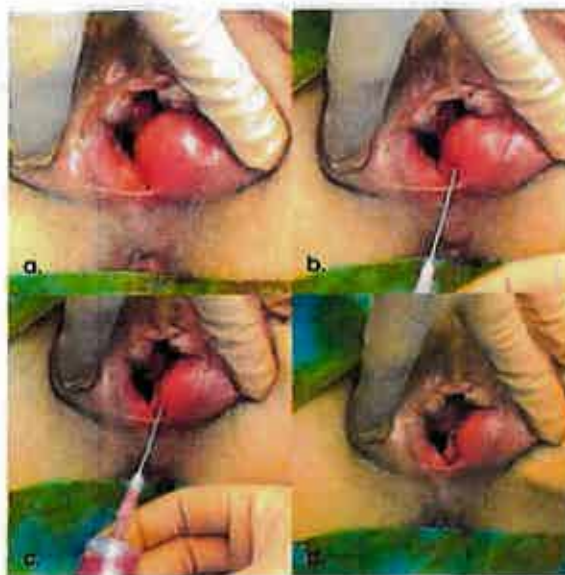
Le geste se réalisera alors comme suit, chez une patiente installée en position gynécologique :

(a) : exposition de l'abcès après élargissement des petites lèvres, puis **anesthésie locale par pulvérisation de LICODAÏNE 5% en nébulisation**, pouvant être associée à de l'hypno-analgésie voire à l'emploi de PROTOXYDE D'AZOTE à visée sédatrice selon l'EVA de la patiente.

(b) : ponction à l'aiguille de calibre 18 montée sur une seringue de 20 ml, dans la partie la plus déprimée de l'abcès.

(c) : évacuation de la collection par aspiration.

(d) : contrôle clinique en fin de procédure : collection diminuée en taille, moins palpable.



Il conviendra dans ces conditions d'informer la patiente de l'intérêt **antalgique** du geste une fois la douleur de l'insertion de l'aiguille passée, de son intérêt **bactériologique** (envoi des prélèvements en analyse), mais aussi du **risque d'échec** de la procédure, aboutissant à une prise en charge chirurgicale ultérieure (**50% des cas**).

Le traitement associera alors un traitement antibiotique par **PRISTINAMYCINE 1 gramme 3 fois par jour durant 7 jours** à la ponction-aspiration de la collection.

Une attention particulière sera portée aux résultats d'analyses bactériologiques avec éventuelle adaptation thérapeutique ultérieure en cas de résistance retrouvée à l'antibiogramme.

Une consultation de réévaluation clinique est encouragée au **7^{ème} jour**.

c. Prise en charge chirurgicale d'emblée

Par voie de conséquence, en cas de :

- Terrain à **risque** (immunosuppression, diabète, grossesse, etc) ;
- Antibiothérapie en cours **inefficace** et **aggravation importante** des symptômes et des signes locaux ;
- **Signes de gravité** (fièvre, adénopathies, extension loco-régionale, etc) ;
- Collection de **taille supérieure à 5 cm** ;
- Ou par souhait de la patiente ;

Une prise en charge chirurgicale d'emblée de l'abcès peut être réalisée, par incision-drainage.

La patiente sera alors informée du risque de récurrence ultérieure (allant jusqu'à 42% dans certaines études (3)), des risques hémorragique et infectieux intrinsèques à ce type de procédure, ainsi que du risque de douleurs chroniques et dyspareunies.

En cas de Bartholinite multirécidivante, une ablation totale de la, voire des, glande(s) peut être proposée à la patiente. Dans ce cas, il apparaît primordial de l'informer que ce geste est considéré comme dépourvu de conséquence sur la lubrification vaginale au cours des rapports sexuels (y compris lorsque les deux glandes sont retirées).